MÓDULO 7 · INVESTIGACIÓN CLÍNICA, RWE Y GENERACIÓN DE EVIDENCIA

Gaps de evidencia

Un gap de evidencia es una pregunta clínica o científica relevante para la práctica médica —o para la toma de decisiones de pacientes, pagadores o reguladores— que la evidencia disponible actualmente no responde de forma satisfactoria. Identificar estos gaps de forma sistemática, y no solo intuitiva, es una de las contribuciones más estratégicas que un MSL puede hacer, porque conecta directamente el trabajo de campo con la planificación de investigación futura.

GAP DE EVIDENCIA

- Pregunta clínica relevante que la evidencia actual no responde satisfactoriamente
- Identificarlos de forma sistemática es una contribución estratégica del MSL
- Conecta el trabajo de campo con la planificación de investigación futura

Los gaps de evidencia pueden originarse en distintos niveles. Pueden ser gaps de población: los ensayos pivotales, por sus criterios de inclusión, a menudo excluyen a pacientes de edad avanzada, con múltiples comorbilidades, con insuficiencia renal o hepática, embarazadas, o pertenecientes a determinados grupos étnicos infrarrepresentados, dejando sin respuesta clara cómo se comporta el tratamiento en esos subgrupos que sí aparecen en la práctica clínica real. Pueden ser gaps comparativos: muchos ensayos pivotales se diseñan frente a placebo o frente a un comparador que ya no representa el estándar de cuidado actual, dejando sin respuesta directa la pregunta más práctica para un clínico, "¿cómo se compara esto frente a la alternativa que uso hoy?". Pueden ser gaps de resultado: ausencia de datos sobre resultados a muy largo plazo, sobre calidad de vida, sobre resultados reportados por el propio paciente, o sobre el impacto económico y de carga asistencial del tratamiento. Y pueden ser gaps de implementación: incertidumbre sobre cómo aplicar de forma óptima una intervención en la práctica real, más allá de si funciona en condiciones ideales.

Tipos de gaps de evidencia

→ **Gaps de población**
→ **Gaps comparativos**
→ **Gaps de resultado**
→ **Gaps de implementación**

El proceso para identificar gaps de evidencia de forma rigurosa combina varias fuentes: una revisión sistemática o de alcance (scoping review) de la literatura existente, que permite mapear qué preguntas ya tienen respuesta consolidada y cuáles no; el análisis de guías clínicas, que a menudo señalan explícitamente áreas de incertidumbre o recomendaciones basadas en consenso de expertos más que en

evidencia de alta calidad; y, de forma crucial para el MSL, los insights recogidos directamente de la interacción con KOLs, clínicos e investigadores, que con frecuencia identifican gaps prácticos antes de que aparezcan formalizados en la literatura.

CÓMO SE IDENTIFICAN LOS GAPS RIGUROSAMENTE

- Revisión sistemática o de alcance (scoping review) de la literatura existente
- Análisis de guías clínicas, que señalan áreas de incertidumbre
- Insights recogidos de la interacción con KOLs, clínicos e investigadores

Una vez identificado, un gap de evidencia no se traduce automáticamente en un nuevo estudio: debe evaluarse su relevancia clínica (¿a cuántos pacientes afecta y con qué impacto?), su viabilidad metodológica (¿es posible diseñar un estudio que lo responda con rigor?) y su alineamiento con la estrategia médica del producto. Este proceso de priorización es habitualmente responsabilidad conjunta de Medical Affairs, HEOR y los equipos de evidencia clínica, con el MSL aportando la perspectiva del terreno que valida —o matiza— la relevancia percibida de cada gap.

- Debe evaluarse su relevancia clínica, viabilidad metodológica y alineamiento estratégico
- Responsabilidad conjunta de Medical Affairs, HEOR y equipos de evidencia clínica
- El MSL aporta la perspectiva del terreno que valida o matiza cada gap

Un MSL que documenta y comunica gaps de evidencia de forma estructurada, en lugar de mencionarlos de forma anecdótica, incrementa notablemente la probabilidad de que esos insights se traduzcan en estudios reales que, eventualmente, cierren esas mismas preguntas sin respuesta.

- Documentar y comunicar los gaps de forma estructurada, no anecdótica
- Aumenta la probabilidad de que se traduzcan en estudios reales
- Esos estudios eventualmente cierran las preguntas sin respuesta